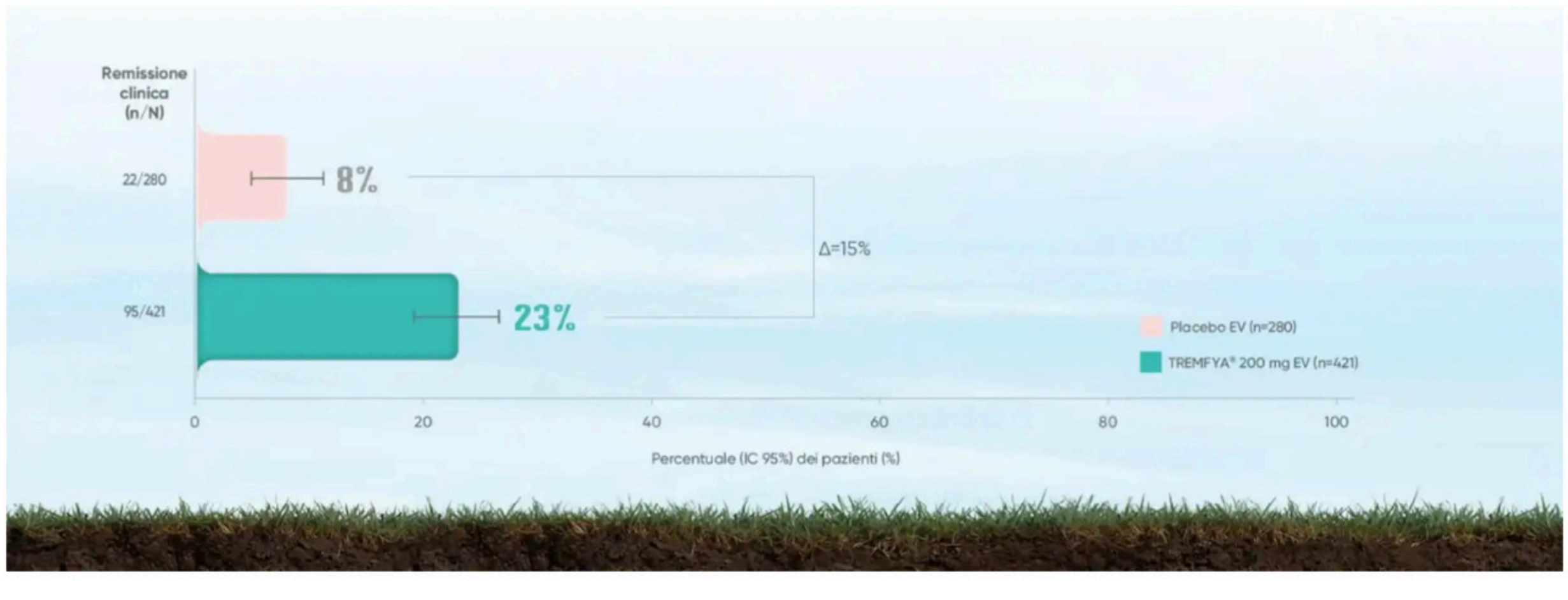
TREMFYA® è indicato per il trattamento di pazienti adulti con UC attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico[1]

Nella fase di mantenimento dello studio QUASAR complessivamente il 34% (129 su 378) dei pazienti nei gruppi TREMFYA® ha raggiunto la remissione endoscopica alla Settimana 44 di mantenimento[2]

Una maggiore proporzione di pazienti trattati con TREMFYA® 100 mg SC ogni 8 settimane o 200 mg SC ogni 4 settimane ha raggiunto una combinazione di remissione sintomatica, normalizzazione endoscopica, remissione istologica e calprotectina fecale ≤ 250 mg/kg alla Settimana 44 rispetto al placebo (rispettivamente 22% e 28% verso 9%)[1]

Efficacia alla Settimana 12 nello studio di induzione

Con TREMFYA® una percentuale significativamente maggiore di pazienti ha ottenuto una remissione clinica alla Settimana 12 nella fase 3 dello studio di induzione[2#]



Rappresentazione grafica di dati testuali di Rif. 2

[#] Nella fase 3 dello studio di induzione, una percentuale significativamente maggiore di pazienti trattati con TREMFYA® ha raggiunto la remissione clinica alla Settimana 12 (endpoint primario; 23% [95 di 421 pazienti]) rispetto ai pazienti trattati con placebo (8% [22 di 280 pazienti]; differenza aggiustata tra i trattamenti [Δ] 15%, IC 95%: 10-20).[2]

Un miglioramento sintomatico è stato osservato già a partire dalla Settimana 1 di induzione (primo timepoint valutato), con una percentuale maggiore di pazienti trattati con TREMFYA® rispetto a quelli trattati con placebo che hanno raggiunto una risposta sintomatica e un sottopunteggio di frequenza delle evacuazioni pari a 0 o 1 alla Settimana 1 di induzione e a ogni timepoint successivo fino alla Settimana 12 di induzione[2]

Rispetto al placebo, una percentuale significativamente maggiore di pazienti trattati con TREMFYA® ha raggiunto la remissione sintomatica alle Settimane 4 e 12 di induzione (endpoint secondari principali) e sono stati osservati maggiori miglioramenti nel sanguinamento rettale dalla Settimana 1 alla 12 di induzione[2]

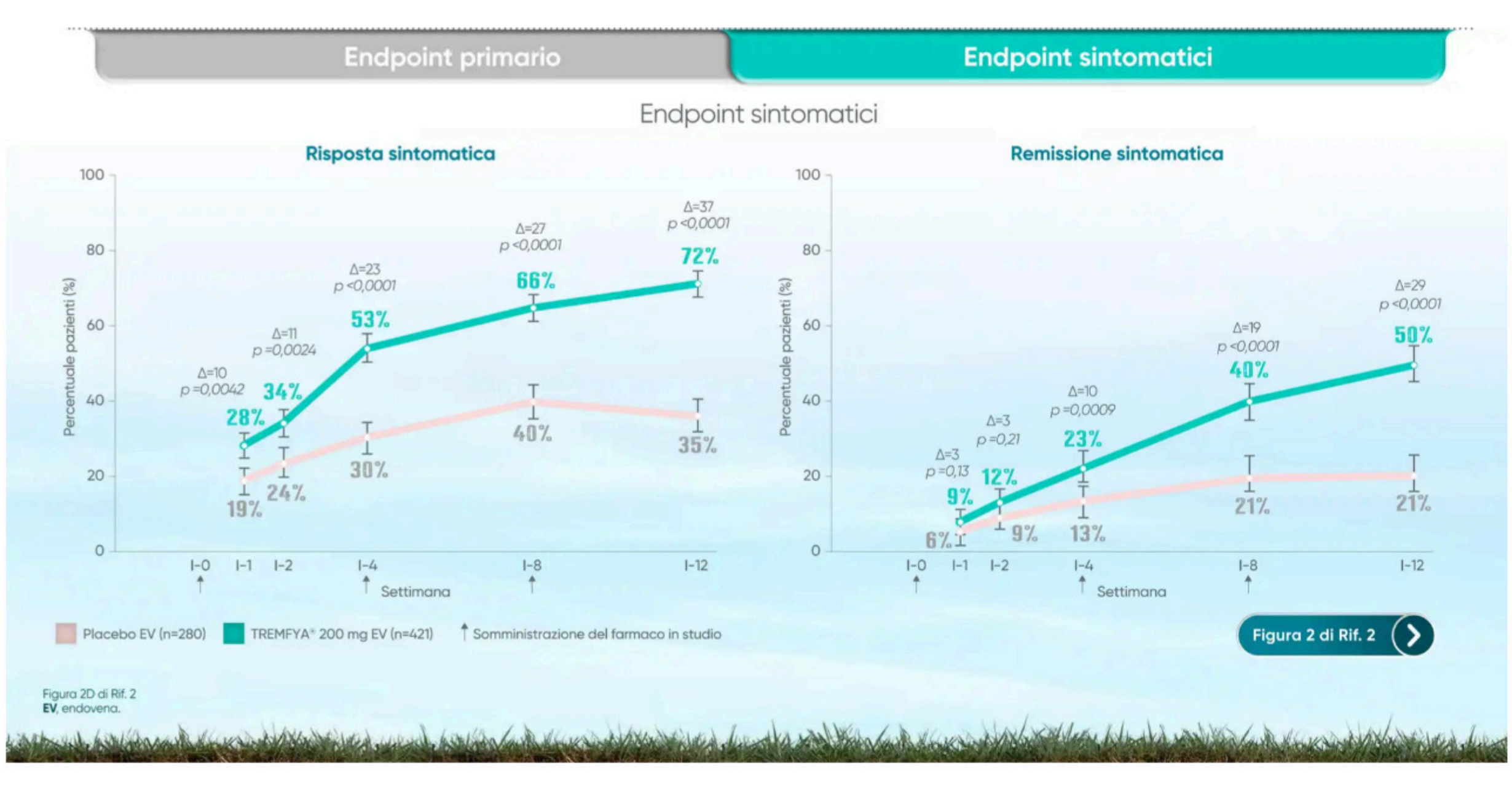


Figura 2 (parziale) di Rif. 2

Efficacia alla Settimana 44 nello studio di mantenimento

Nello studio di mantenimento, entrambi i regimi posologici di TREMFYA® hanno mostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, misurata dalla remissione clinica alla Settimana 44 di mantenimento (endpoint primario) e da tutti i principali endpoint secondari alla Settimana 44 di mantenimento[2]

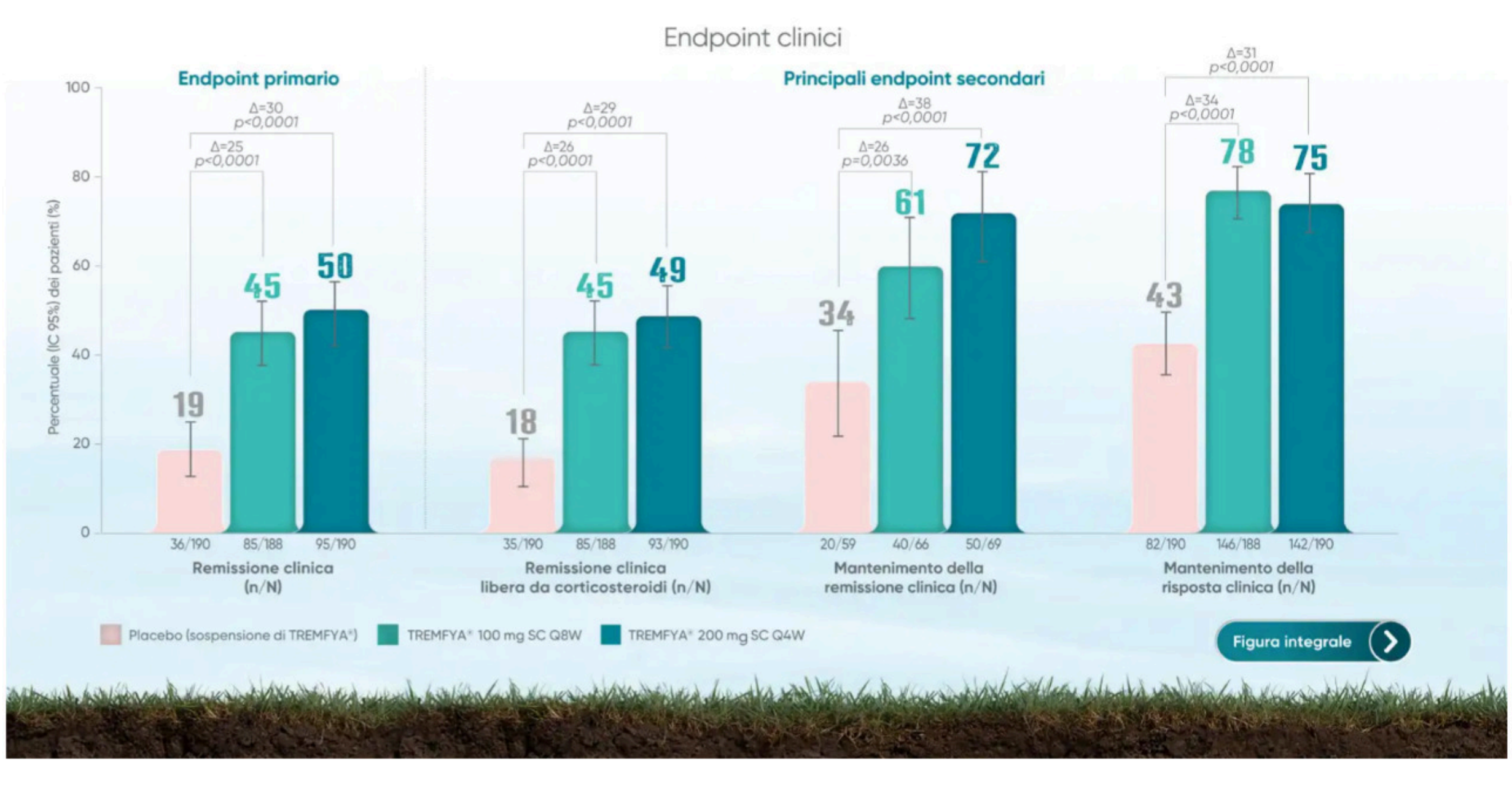


Figura 4 (parziale) di Rif. 2

QUASAR: Disegno degli studi clinici[2]

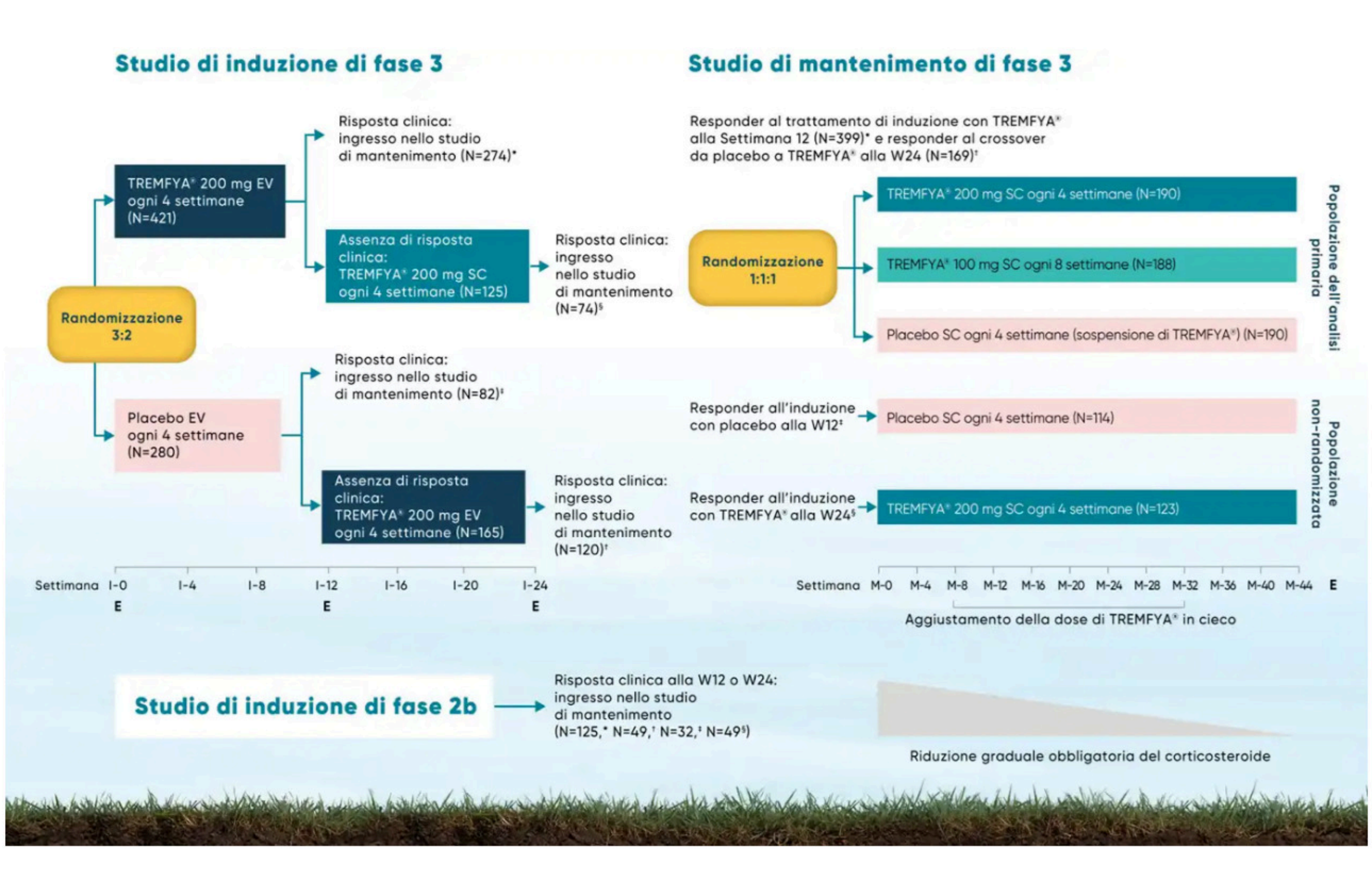

Studio di induzione di fase 3
Randomizzazione 3:2
TREMFYA® 200 mg EV ogni 4 settimane (N=421)
Risposta clinica: ingresso nello studio di mantenimento (N=274)*
Assenza di risposta clinica: TREMFYA® 200 mg SC ogni 4 settimane (N=125)
Risposta clinica: ingresso nello studio di mantenimento (N=74)§
Placebo EV ogni 4 settimane (N=280)
Risposta clinica: ingresso nello studio di mantenimento (N=82)‡
Assenza di risposta clinica: TREMFYA® 200 mg EV ogni 4 settimane (N=165)
Risposta clinica: ingresso nello studio di mantenimento (N=120)†
Settimana I-0 I-4 I-8 I-12 I-16 I-20 I-24
E E E
Studio di mantenimento di fase 3
Responder al trattamento di induzione con TREMFYA® alla Settimana 12 (N=399)* e responder al crossover da placebo a TREMFYA® alla W24 (N=169)†
Randomizzazione 1:1:1
TREMFYA® 200 mg SC ogni 4 settimane (N=190)
TREMFYA® 100 mg SC ogni 8 settimane (N=188)
Placebo SC ogni 4 settimane (sospensione di TREMFYA®) (N=190)
Popolazione dell'analisi primaria
Responder all'induzione con placebo alla W12‡
Placebo SC ogni 4 settimane (N=114)
Responder all'induzione con TREMFYA® alla W24§
TREMFYA® 200 mg SC ogni 4 settimane (N=123)
Popolazione non-randomizzata
Settimana M-0 M-4 M-8 M-12 M-16 M-20 M-24 M-28 M-32 M-36 M-40 M-44 E
Aggiustamento della dose di TREMFYA® in cieco
Studio di induzione di fase 2b
Risposta clinica alla W12 o W24: ingresso nello studio di mantenimento (N=125,* N=49,† N=32,‡ N=49§)
Riduzione graduale obbligatoria del corticosteroide

Figura 1 di Rif. 2

I dati della popolazione includono solo pazienti con un punteggio Mayo modificato (mMayo) basale compreso tra 5 e 9.

La risposta clinica si è basata sui dati del sistema di risposta web interattivo, utilizzando il sottopunteggio endoscopico Mayo assegnato dall'endoscopista locale in cieco. Quattro gruppi di pazienti provenienti dagli studi di induzione sono entrati nello studio di mantenimento:

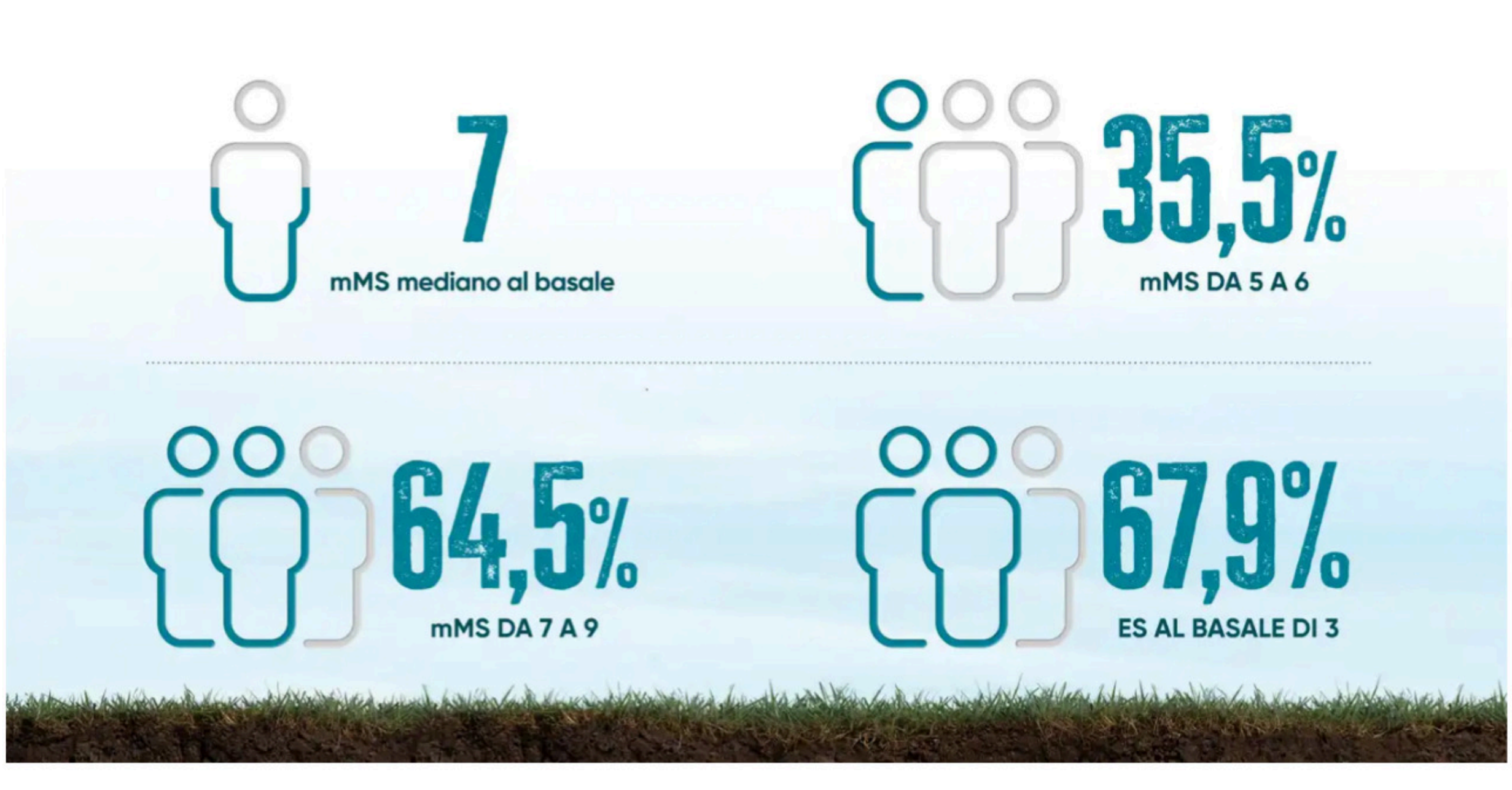
* responder all'induzione con TREMFYA® alla Settimana 12 (randomizzati);
† responder all'induzione del passaggio da placebo a TREMFYA® alla Settimana 24 (randomizzati);
‡ responder all'induzione con placebo alla Settimana 12 (non randomizzati);
§ responder all'induzione con TREMFYA® alla Settimana 24 (non randomizzati).

I pazienti randomizzati che soddisfacevano i criteri di perdita di risposta clinica tra le Settimane di mantenimento 8 e 32 erano eleggibili per un aggiustamento della dose in cieco come segue: da placebo somministrato SC a TREMFYA® 200 mg somministrato SC Q4W (trattamento di salvataggio), da TREMFYA® 100 mg somministrato SC Q8W a TREMFYA® 200 mg somministrato SC Q4W, da TREMFYA® 200 mg somministrato SC Q4W a TREMFYA® 200 mg somministrato SC Q4W (aggiustamento della dose simulata).[2]

Gli endpoint primari erano la remissione clinica alla Settimana 12 di induzione nello studio di fase 3 di induzione e la remissione clinica alla Settimana 44 di mantenimento nello studio di mantenimento[2]

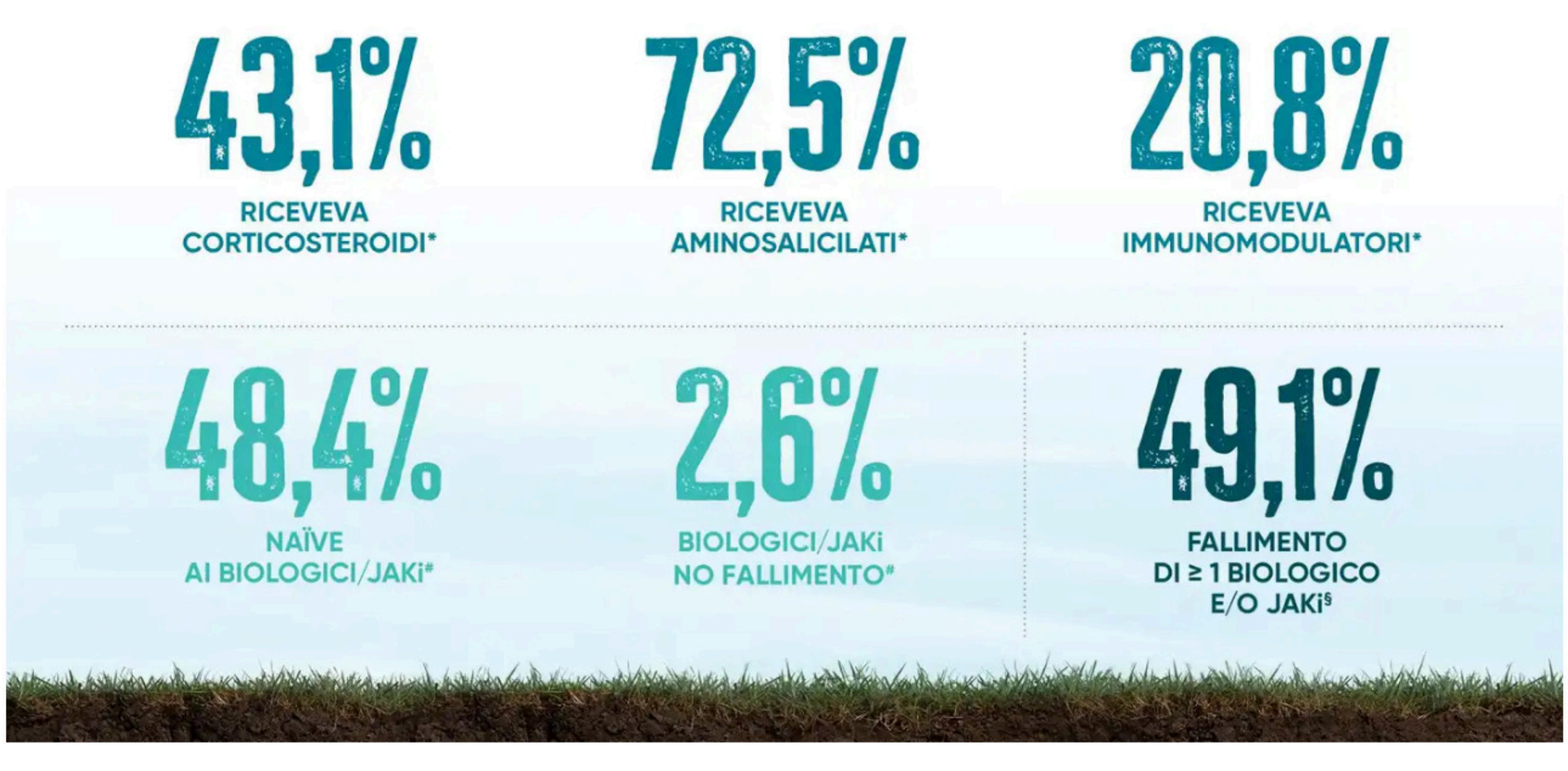
Caratteristiche dei pazienti dello studio QUASAR

Caratteristiche della malattia al basale



Rappresentazione grafica di dati testuali di Rif. 1

Al basale, l'mMS mediano era 7, con il 35,5% dei pazienti con mMS al basale compreso tra 5 e 6 e il 64,5% con mMS compreso tra 7 e 9 e il 67,9% dei pazienti con ES al basale pari a 3.[1]


43,1%
RICEVEVA CORTICOSTEROIDI*
72,5%
RICEVEVA AMINOSALICILATI*
20,8%
RICEVEVA IMMUNOMODULATORI*
48,4%
NAÏVE AI BIOLOGICI/JAKi#
2,6%
BIOLOGICI/JAKi NO FALLIMENTO#
49,1%
FALLIMENTO DI ≥ 1 BIOLOGICO E/O JAKi§

Rappresentazione grafica di dati testuali di Rif. 1

Al basale, il 72,5% dei pazienti riceveva aminosalicilati, il 20,8% dei pazienti riceveva immunomodulatori (MTX, 6-MP o AZA) e il 43,1% dei pazienti riceveva corticosteroidi.[1]

In totale, il 48,4% dei pazienti era naïve alla terapia biologica e ai JAK inibitori mentre il 2,6% aveva ricevuto in precedenza un farmaco biologico o un JAK inibitore, ma non aveva fallito.[1]

In totale, il 49,1% dei pazienti aveva precedentemente fallito almeno una terapia biologica e/o un JAK inibitore.[1]

Abbreviazioni

6-MP: mercaptopurina; **AZA:** azatioprina; **E:** endoscopia; **ES:** punteggio endoscopico; **EV:** per via endovenosa; **I:** induzione; **IBDQ:** Questionario sulla malattia infiammatoria intestinale; **IC:** intervallo di confidenza; **JAKi:** inibitori della Janus Chinasi; **M:** mantenimento; **mMS:** punteggio Mayo modificato; **MTX:** metotrexato; **n/N:** numero di pazienti/pazienti totali; **Q4W:** ogni 4 settimane; **Q8W:** ogni 8 settimane; **SC:** per via sottocutanea; **UC:** ulcerative colitis, colite ulcerosa; **W:** week, settimana.

TREMFYA 200 mg - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino - 20 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino - AIC 045772050 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772086 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla) - AIC 045772074 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla) - AIC 045772098 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

L'induzione sottocute è al momento rimborsata solo in malattia di Crohn.

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 siringa preriempita - AIC n. 045772011 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - penna preriempita - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC n. 045772023 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772100 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopracitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni psoriasi a placche, artrite psoriasica, malattia di Crohn e colite ulcerosa.

Rimborsabilità delle indicazioni psoriasi a placche, malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

RCP TREMFYA 100 mg OnePress e PushPen
SCARICA

RCP TREMFYA 100 mg Siringa
SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg PFS/PFP
SCARICA

RCP TREMFYA 200 mg EV
SCARICA

Bibliografia

1. TREMFYA® Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
2. Rubin DT, et al. Lancet. 2025;405(10472):33-49.

Codice AIFA: CP-603518
Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il: XX/XX/2026
VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

Johnson & Johnson
Resta in contatto
© Janssen-Cilag S.p.A., società del gruppo Johnson & Johnson, viale Fulvio Testi 280/6, 20126 Milano. Questo sito è pubblicato da Janssen-Cilag SpA che è l'unica responsabile dei contenuti presenti. Cap. Soc. €25.000.000,00 i.v. - Registro Imprese MI e Codice Fiscale 00962280590 - Partita IVA 02707070963 - R.E.A. 1454254. Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Società Johnson & Johnson. Questo sito è destinato ai visitatori residenti in Italia.
Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2026

FIGURA 2 INTEGRALE DI RIF. 2

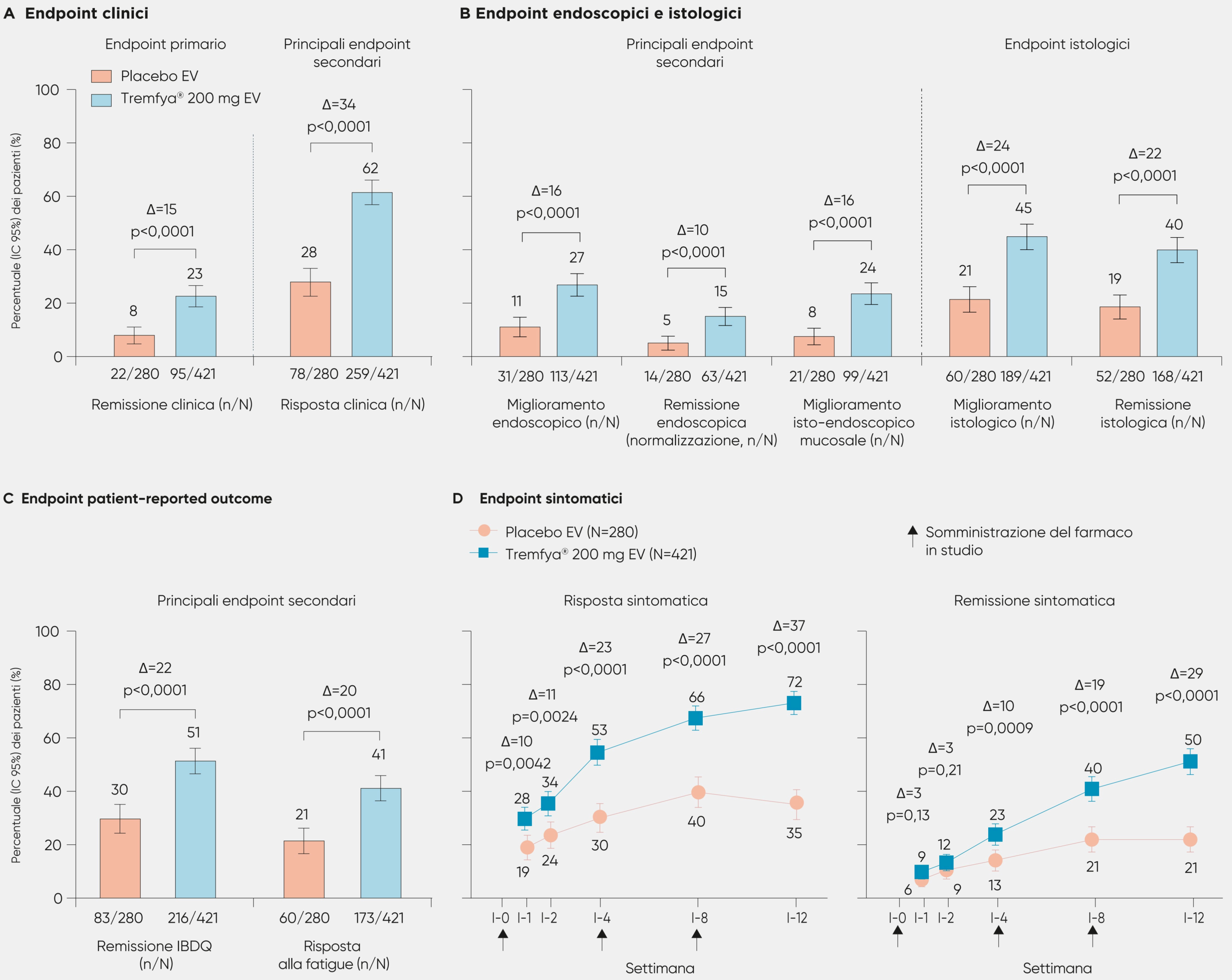


Figura 2 di Rif. 2:
Endpoint primari, secondari maggiori e istologici alla settimana 12 di induzione nello studio di fase 3 di induzione (popolazione dell'analisi primaria)
I confronti tra Tremfya® e placebo per tutti gli endpoint sono stati controllati per molteplicità, ad eccezione della remissione endoscopica (p nominale <0,0001, data la gerarchia di test), del miglioramento istologico, della remissione istologica e di tutti gli endpoint sintomatici (ad eccezione della remissione sintomatica alle settimane 2, 4 e 12 di induzione, che erano endpoint secondari maggiori controllati per molteplicità).
I valori di p per gli endpoint non controllati per molteplicità sono nominali.
La risposta sintomatica fino alla settimana 12 di induzione e la remissione sintomatica alla settimana 1 di induzione sono state post hoc.
Le differenze di trattamento aggiustate (IC al 95%) sono state le seguenti: remissione clinica, 15% (IC al 95% da 10 a 20); risposta clinica, 34% (da 27 a 41); miglioramento endoscopico, 16% (da 11 a 21); remissione endoscopica, 10% (da 6 a 14); miglioramento della mucosa isto-endoscopica, 16% (da 11 a 21); miglioramento istologico, 24% (da 17 a 30); remissione istologica, 22% (da 15 a 28); remissione IBDQ, 22% (da 15 a 29); risposta alla *fatigue*, 20% (da 13 a 26); risposta sintomatica alla settimana 1 di induzione, 10% (da 3 a 16), settimana 2 di induzione, 11% (da 4 a 17), settimana 4 di induzione, 23% (da 16 a 30), settimana 8 di induzione, 27% (da 20 a 34) e settimana 12 di induzione, 37% (da 30 a 44); e remissione sintomatica alla settimana 1 di induzione, 3% (da −1 a 7), settimana 2 di induzione, 3% (da −2 a 8), settimana 4 di induzione, 10% (da 4 a 15), settimana 8 di induzione, 19% (da 13 a 26) e settimana 12 di induzione, 29% (da 23 a 36).

I=induzione. IBDQ=Questionario sulla malattia infiammatoria intestinale.
n/N=numero di pazienti/pazienti totali.

FIGURA 4 INTEGRALE DI RIF. 2

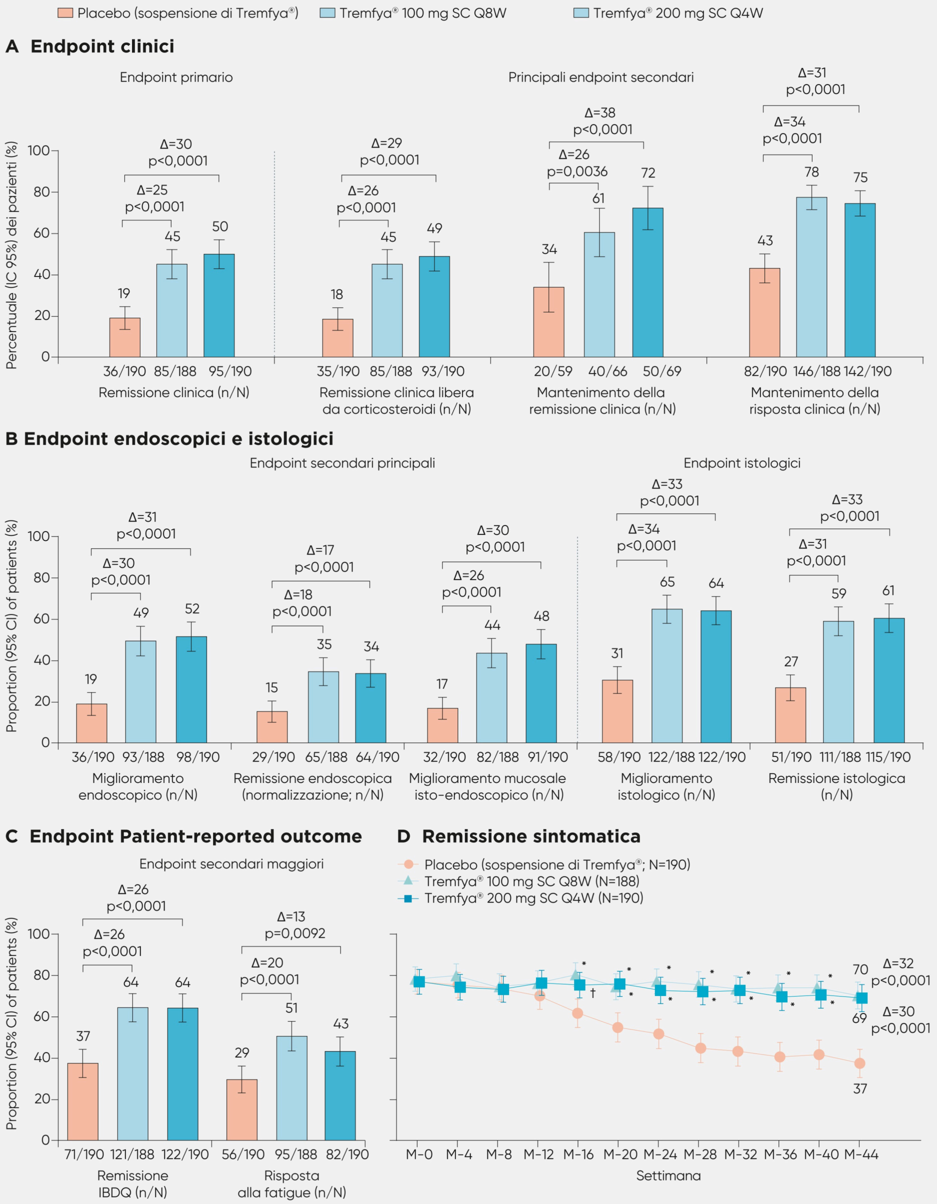


Figura 4 di Rif. 2.
Endpoint primari, secondari maggiori e istologici alla settimana 44 di mantenimento nello studio di mantenimento (popolazione dell'analisi primaria che includeva solo pazienti randomizzati e trattati).

Tutti gli endpoint per Tremfya® e placebo erano controllati per molteplicità, ad eccezione del miglioramento istologico, della remissione istologica e della remissione sintomatica (ad eccezione della settimana 44 di mantenimento, che era un endpoint secondario maggiore controllato per molteplicità).

Le differenze di trattamento aggiustate (IC al 95%) per Tremfya® 100 mg somministrato per via sottocutanea ogni 8 settimane e Tremfya® 200 mg somministrato per via sottocutanea ogni 4 settimane, rispettivamente, erano del 25% (IC al 95% 16-34) e del 30% (21-38) per la remissione clinica, del 26% (17-34) e del 29% (21-38) per la remissione clinica libera da corticosteroidi, del 26% (9-42) e del 38% (23-54) per il mantenimento della remissione clinica, del 34% (24-43) e del 31% (22-40) per il mantenimento della risposta clinica, del 30% (21-38) e del 31% (22-40) per il miglioramento endoscopico, del 18% (10-27) e del 17% (9-25) per la remissione endoscopica, del 26% (17–34) e 30% (21–38) per il miglioramento mucosale isto-endoscopico, 34% (24–43) e 33% (23–42) per il miglioramento istologico, 31% (22–41) e 33% (24–42) per la remissione istologica, 26% (17–36) e 26% (16–35) per la remissione IBDQ, 20% (11–30) e 13% (3–22) per la risposta alla Fatigue e 32% (23–41) e 30% (21–40) per la remissione sintomatica alla settimana 44 del trattamento di mantenimento.

IBDQ=Questionario sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
M=trattamento di mantenimento.
n/N=numero di pazienti/pazienti totali.
*P nominale < 0,0001 rispetto al placebo.
†P nominale = 0,0066 rispetto al placebo.